Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Campo Grande
5ª Vara Cível

Autos n° 0830954-46.2024.8.12.0001
Ação: Procedimento Comum Cível
Autor: Pablo Neves Chaves
Réu: Unimed - Campo Grande MS Cooperativa de Trabalho Médico

SENTENÇA

I - RELATÓRIO

PABLO NEVES CHAVES, com qualificação nos autos, propôs **AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA** em face de **UNIMED - CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO**, também com qualificação nos autos, formulando os seguintes pedidos:

> ***"Ao final, a total procedência dos pedidos, tornando definitiva a tutela de urgência deferida, bem como para:***
>
> ***a) Ratificar, tornando definitiva a medida liminar concedida para condenar a Ré ao fornecimento do medicamento denominado Xyrem® , uso contínuo e ininterrupto por tempo indeterminado, sendo sua posologia 6 frascos de 180 ml cada, suficientes para dois meses de tratamento, ou seja, 36 FRASCOS/ANO, necessário para tratamento nos termos do relatório e prescrição médica, necessário para tratamento contido nos termos do laudo e prescrição médica. O tratamento deverá ser contínuo e o fornecimento de forma vitalícia, enquanto entender a necessidade do tratamento médico, conforme consta no relatório médico anexado;***
>
> ***b) Condenar a Requerida ao pagamento pelos danos morais causados ao Autor, em valor não inferior do que 40 salários mínimos nacionais vigentes da época do pagamento".***

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WILSON LEITE CORREA, liberado nos autos em 12/02/2025 às 17:34 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0830954-46.2024.8.12.0001 e código Xj6HINb0.

Como causa de pedir, sustenta que é beneficiário do plano de saúde requerido.

Esclareceu que foi diagnosticado como sendo portador de doença crônica grave denominada NARCOLEPSIA TIPO I COM CATAPLEXIA.

Sustentou já realizou diversos tratamentos clínicos para controlar a evolução da doença, no entanto, os mesmos não foram frutíferos.

Afirmou que, em razão da gravidade do caso e dos sintomas, foi-lhe prescrito o medicamento XYREM® - oxibato de sódio.

Aduziu que tal medicamento não é fabricado no Brasil e não possui registro na ANVISA, de modo que postulou à ANVISA a importação de tal medicamento, o que foi deferido.

Relatou que, na data de 14/05/2024, solicitou à requerida o fornecimento de tal medicamento, nos termos indicados pelo seu médico, no entanto, a requerida negou cobertura, sob o fundamento de que o medicamento XYREM® - oxibato de sódio é de uso ambulatorial e não pode ser fornecido para uso domiciliar, bem como que o mesmo não está no rol da ANS.

Por tais motivos, requereu a antecipação dos efeitos da tutela, aduzindo presentes os requisitos legais necessários ao seu deferimento, para a finalidade de determinar que a parte requerida autorize/forneça o medicamento XYREM® - oxibato de sódio, nos termos da solicitação indicada pelo médico especialista.

Na decisão de fls. 108/117 foi deferida a tutela de urgência requerida pela parte autora para o fim de determinar que a parte requerida autorize o início do tratamento com o medicamento XYREM® - oxibato de sódio, nos exatos termos solicitados pelo médico da parte autora pelo prazo de 06 (seis) meses.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WILSON LEITE CORREA, liberado nos autos em 12/02/2025 às 17:34 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0830954-46.2024.8.12.0001 e código Xj6HINb0.

A parte ré foi citada, sendo que compareceu aos autos e ofertou contestação (fls. 250/268), alegando, em síntese o seguinte: 1) aduz que o medicamento solicitado é uso domiciliar e não está vinculado a tratamento oncológico; 2) afirma que tal medicamento não estão no rol da ANS, de modo que não tem cobertura contratual; 3) aduz que não estão presentes os elementos da responsabilidade civil a ensejar indenização por danos morais; 4) pugna pela improcedência dos pedidos iniciais.

A parte autora impugnou os termos da contestação na manifestação de fls. 415/435.

Foi designada audiência de conciliação, a qual restou sem êxito (fls. 247/248).

As partes foram instadas a especificar as provas que pretendem produzir e postularam o seguinte: 1) a parte autora requereu o julgamento antecipado da lide (fls. 540/545); e 2) a parte ré requereu a produção de prova documental, pericial, testemunhal e o depoimento pessoal do autor (fls. 538/539).

Às fls. 546/550, a parte autora requereu a prorrogação dos efeitos da decisão que deferiu a tutela de urgência.

Instada a se manifestar, a parte requerida pugnou pelo indeferimento do pedido (fls. 554/555).

II - FUNDAMENTAÇÃO

Em que pese a requerida tenha pugnado pela produção de prova pericial e oral, com a finalidade de comprovar a efetividade do tratamento requerido ao autor, tais requerimentos devem ser indeferidos.

Com efeito, a realização de perícia para provar a alegação de

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WILSON LEITE CORREA, liberado nos autos em 12/02/2025 às 17:34 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0830954-46.2024.8.12.0001 e código Xj6HINb0.

que o tratamento requerido pelo autor não era indicado à sua patologia é desnecessária, uma vez que o pedido está amparado em laudo do profissional que o acompanhava.

Ademais, o pleito nos termos em que está formulado, aparentemente, busca firmar uma premissa de julgamento para o feito, o que é processualmente inadequado, posto que constituiria tentativa de obter um "parecer" para substituir a prescrição do médico que realiza o tratamento do autor.

Deve ser considerado, também, que a matéria posta à apreciação não necessita de produção de prova oral, uma vez que os pontos controvertidos dizem respeito à suposta obrigação da requerida de fornecer o tratamento solicitado pelo médico do autor, e tais fatos, na situação em tela, provam-se por documentos, sendo que a realização de audiência de instrução e julgamento demandaria em dilação probatória desnecessária, bem como vislumbra-se que os documentos juntados aos autos são suficientes para apreciação da presente demanda.

Ressalta-se que, na atividade de julgar, nos termos do art. 371 do Código de Processo Civil, ***"O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento"***, de modo que a análise de eventual obrigação de fazer deve ser realizada levando-se em consideração as resoluções atinentes ao caso e ao Código Civil.

Na espécie, incide o disposto no at. 355, I, do Código de Processo Civil, no qual assevera que "***O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas".***

Em decisões recentes o E. TJ/MS, em ações com matéria idêntica à posta nestes autos, decidiu que nessa situação é viável o julgamento antecipado e não há que se falar em cerceamento de defesa, como se vê dos julgados a seguir transcritos:

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WILSON LEITE CORREA, liberado nos autos em 12/02/2025 às 17:34 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0830954-46.2024.8.12.0001 e código Xj6HINb0.

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – PLANO DE SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO PRESCRITO POR PROFISSIONAL ESPECIALISTA – COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE PARA ASSEGURAR A SAÚDE DO AUTOR – RESOLUÇÃO DA ANS – ROL EXEMPLIFICATIVO – RECUSA ABUSIVA E CAUSA PARA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE – PREQUESTIONAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não cabe o acolhimento da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa quando verificado que a dilação de provas postulada pela parte recorrente mostra-se desnecessária. O plano de saúde deve fornecer o tratamento médico prescrito pelo médico especialista, ante a comprovação da necessidade do tratamento para assegurar a saúde do autor. O fato de o tratamento pleiteado pela parte não constar no rol da ANS não exime o plano de saúde em fornecê-lo, uma vez que se trata de previsão mínima de consultas, exames e tratamentos que devem ser disponibilizados pelo plano de saúde, sendo tal rol considerado meramente exemplificativo e sem caráter vinculativo. A jurisprudência no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de responsabilidade contratual, a recusa injustificada de cobertura de tratamento de saúde é capaz de ensejar a condenação por dano moral. Por um critério de razoabilidade, a indenização pelo dano moral deve ser fixada tendo em vista os transtornos gerados e a capacidade econômica do ofensor, atendendo aos objetivos da reparação civil, quais sejam, a compensação do dano, a punição ao causador do dano e a desmotivação social da conduta lesiva". ([1]).

"APELAÇÃO CÍVEL- PLANO DE SAÚDE-ENTIDADE DE AUTOGESTÃO- PRELIMINAR REJEITADA- CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONSTATADO- TERAPIA ABA- NEGATIVA DE COBERTURA- ABUSIVIDADE- ROL DA ANS- MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO- COPARTICIPAÇÃO- COBRANÇA INDEVIDA- AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL- SENTENÇA MANTIDA- RECURSO IMPROVIDO Se o magistrado compreender que a produção de novas provas trata-se de providência inútil, que em nada acrescentará ao seu convencimento, ressai como dever e não como faculdade o julgamento antecipado da lide, a teor do que dispõe o art.355, I, do CPC. Portanto, se o julgador formou seu convencimento, sentindo-se apto a apreciar o mérito da causa com o conjunto probatório constante nos autos, não se vislumbra, ante o indeferimento de produção de novas provas, violação do direito fundamental ao processo justo, tampouco cerceamento de defesa. Quando houver previsão contratual de cobertura da doença e respectiva prescrição médica do meio para o restabelecimento da saúde, é dever da operadora de plano de saúde oferecer o tratamento indispensável ao usuário, considerando-se abusiva a negativa de cobertura, ao argumento de que a terapia

[1] **TJMS**. Apelação Cível n. 0824757-17.2020.8.12.0001, Campo Grande, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Marcelo Câmara Rasslan, j: 28/06/2021, p: 01/07/2021.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WILSON LEITE CORREA, liberado nos autos em 12/02/2025 às 17:34 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0830954-46.2024.8.12.0001 e código Xj6HINb0.

postulada não está prevista no rol da ANS, ainda que se trate de entidade de autogestão, a qual, de fato, não se submete às normas consumeristas, nos termos da Súmula 608 do STJ. Isso porque a entidade de autogestão sujeita-se às regras e princípios contratuais inscritos no Código Civil, com os quais não se compatibilizam restrições que desvirtuam a própria natureza do contrato, como a que limita a cobertura pelo plano de saúde aos tratamentos previstos no rol da ANS. A coparticipação exigida pela apelante não encontra previsão no contrato do plano de saúde em questão. Logo, o ofício enviado à clínica e a declaração de ciência assinada pela genitora não ostentam força de avença e não podem, de maneira alguma, vincular o beneficiário do plano, cujo contrato não previu a coparticipação". ([2]).

Logo, **INDEFIRO** a produção de prova pericial e oral requeridas pela requerida.

II.II – MÉRITO

II.II.I – DO PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER

Inicialmente, é importante destacar que a atividade de prestação de assistência médico-hospitalar está abrangida pelo Código de proteção e de Defesa do Consumidor, a teor do que disciplina do artigo 3.º, § 2.º, do CDC, corroborado pelo entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça no enunciado 469.

Em semelhantes litígios deve ocorrer a facilitação da defesa do consumidor em juízo e pode até ser determinada a inversão do ônus da prova, tudo nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, e com base na legislação consumerista, deve-se repelir do contrato firmado entre as partes toda e qualquer cláusula que implique em contrariedade à boa-fé e ao equilíbrio contratual.

Com isso, é possível afirmar que os direitos básicos do consumidor e as suas normas protetivas devem todas ser aplicadas no contrato em questão, principalmente o art. 6.º, V, que estabelece a possibilidade da quebra da base

[2] **TJMS**. Apelação Cível n. 0805791-11.2017.8.12.0001, Campo Grande, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Geraldo de Almeida Santiago, j: 25/05/2020, p: 27/05/2020

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WILSON LEITE CORREA, liberado nos autos em 12/02/2025 às 17:34 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0830954-46.2024.8.12.0001 e código Xj6HINb0.

objetiva do contrato, excetuando, portanto, o princípio do *pacta sun servanda*.

É cediço que não cabe ao plano de saúde delimitar a espécie de procedimento ou tratamento que o paciente pode ter acesso, se este foi resultado de indicação médica, constituindo tal ato verdadeira cláusula abusiva, que afronta diretamente as normas protetivas previstas no art. 51 do Código de Defesa do Consumidor, que assim dispõe:

> ***"Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:***
>
> ***I - impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços ou impliquem renúncia ou disposição de direitos. Nas relações de consumo entre o fornecedor e o consumidor pessoa jurídica, a indenização poderá ser limitada, em situações justificáveis***
>
> ***II - subtraiam ao consumidor a opção de reembolso da quantia já paga, nos casos previstos neste código;***
>
> ***III - transfiram responsabilidades a terceiros;***
>
> ***IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;***
>
> ***VI - estabeleçam inversão do ônus da prova em prejuízo do consumidor;***
>
> ***VII - determinem a utilização compulsória de arbitragem;***
>
> ***VIII - imponham representante para concluir ou realizar outro negócio jurídico pelo consumidor;***
>
> ***IX - deixem ao fornecedor a opção de concluir ou não o contrato, embora obrigando o consumidor;***
>
> ***X - permitam ao fornecedor, direta ou indiretamente, variação do preço de maneira unilateral;***
>
> ***XI - autorizem o fornecedor a cancelar o contrato unilateralmente, sem que igual direito seja conferido ao consumidor;***
>
> ***XII - obriguem o consumidor a ressarcir os custos de cobrança de sua obrigação, sem que igual direito lhe seja conferido contra o fornecedor;***
>
> ***XIII - autorizem o fornecedor a modificar unilateralmente o conteúdo ou a qualidade do contrato, após sua celebração;***
>
> ***XIV - infrinjam ou possibilitem a violação de normas ambientais;***
>
> ***XV - estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor;***
>
> ***XVI - possibilitem a renúncia do direito de indenização por benfeitorias necessárias".***

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WILSON LEITE CORREA, liberado nos autos em 12/02/2025 às 17:34 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0830954-46.2024.8.12.0001 e código Xj6HINb0.

Dessa maneira, verifica-se que é obrigação do plano de saúde disponibilizar o tratamento médico adequado e que foi indicado pelo médico da autora, sendo que eventual limitação contratual a esse direito, conforme preceitua o artigo 51 do aludido Código, deve ser considerada nula.

Logo, constata-se que, via de regra, o tratamento médico adequado e que foi indicado pelo médico do autor, deve ser coberto pelo plano de saúde.

Nesse ponto aliás, a jurisprudência do E. STJ ***"reconhece a possibilidade do plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas."*** (AgRg no REsp 1325733/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 03/02/2016).

No mesmo diapasão, certamente diante da quantidade de demandas sobre a matéria, o E. TJ/SP editou as súmulas 96 e 102, que assim dispõem:

> ***"Súmula 96 - Havendo expressa indicação médica de exames associados a enfermidade coberta pelo contrato, não prevalece a negativa de cobertura do procedimento".***
>
> ***"Súmula: 102 - Havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS".***

Também a jurisprudência do E. TJ/MS trilha no mesmo caminho, como se vê dos julgados a seguir transcritos, os quais foram colhidos entre muitos de igual teor:

> ***"E M E N T A – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – LIMITAÇÃO DE COBERTURA RELATIVA A TRATAMENTO RPG – AUSÊNCIA DE COBERTURA DO TRATAMENTO PELO PLANO DE SAÚDE – CLAUSULA ABUSIVA – RELAÇÃO CONTRATUAL – COBERTURA DE FISIOTERAPIA – NÃO CABE AO PLANO DECIDIR QUAL MÉTODO E SIM AO MÉDICO – TUTELA CONCEDIDA – DECISÃO***

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WILSON LEITE CORREA, liberado nos autos em 12/02/2025 às 17:34 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0830954-46.2024.8.12.0001 e código Xj6HINb0.

REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Não cabe ao plano decidir qual tratamento deve ou não ser utilizado para recuperação da saúde de um paciente. 2. Uma vez disponibilizada a cobertura ela não pode dizer quais procedimentos, materiais ou técnicas serão utilizadas no tratamento da doença para a qual o contrato preveja cobertura" ([3]).

"E M E N T A – AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SÍNDROME MIELODISPLÁSTICAS DO SUBTIPO ANEMIA REFRATÁRIA – DIREITO DO PACIENTE A RECEBER O TRATAMENTO INDICADO PELO MÉDICO QUE O ACOMPANHA – URGÊNCIA DA MEDIDA PARA TRATAMENTO E CONTROLE DA PATOLOGIA QUE PROGRIDE COM POSSIBILIDADE DE ÓBITO – REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA ANTECIPADA DEVIDAMENTE COMPROVADOS – POSSIBILIDADE DE SER PROFERIDA DECISÃO MONOCRÁTICA – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 932, VIII, DO CPC/2015 C/C 138, IV, DO RITJMS – AUSÊNCIA DE ARGUMENTO CAPAZ DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA – RECURSO IMPROVIDO. Diante da presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada, como a prova inequívoca do direito e a verossimilhança das alegações acerca da necessidade do medicamento pleiteado, a decisão a quo deve ser mantida. Diante da autorização de se proferir decisões monocráticas, concedida pela junção dos artigos 932, VIII, do Código de Processo Civil/2015 com o art. 138, IV, do RITJMS, não há que se falar em nulidade. Quando o agravante não apresenta qualquer argumento capaz de infirmar a decisão agravada, inviável a retratação do posicionamento exarado, devendo ser mantido o decisum que negou provimento de plano ao recurso ante a jurisprudência dominante dos Tribunais pátrios" ([4]).

Fora isso, a Lei 14.454/2022 alterou a Lei n.º 9656/1998 - Planos de Saúde, a fim de estabelecer que o rol da ANS não é taxativo.

No presente feito, conforme mencionado na inicial, o medicamento XYREM® - oxibato de sódio, requerido pelo autor, não é fabricado no Brasil e não possui registro na ANVISA.

O Superior Tribunal de Justiça, ao proferir julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos n.º 1.712.163/SP e 1.726.563/SP, firmou tese no Tema 990, no sentido de que ***"as operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA".***

[3] **TJMS**; Agravo de Instrumento - Nº 1406439-42.2017.8.12.0000 - Dourados Relator : Exmo. Sr. Des. Amaury da Silva Kuklinski, julgado em 25/07/2018.
[4] **TJMS**; Agravo Interno - Nº 2000334-79.2018.8.12.0900/50000 - Bela Vista - Relator – Exmo. Sr. Des. Claudionor Miguel Abss Duarte, julgado em 25/07/2018.

Mod. 990080506 - Endereço: Rua da Paz, nº 14, Jardim dos Estados - 3º andar - Bloco III - CEP 79002-919, Fone: 3317-3369, Campo Grande-MS - E-mail: cgr-5vciv@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WILSON LEITE CORREA, liberado nos autos em 12/02/2025 às 17:34 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0830954-46.2024.8.12.0001 e código Xj6HINb0.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Campo Grande
5ª Vara Cível

Ocorre que, o próprio Superior Tribunal de Justiça tem decidido que ***"embora se trate de fármaco importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação excepcionalmente autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde"*** ([5]).

No caso em tela, reputo que se aplica a exceção acima mencionada.

Com efeito, através do documento juntado às fls. 39/41, o autor comprova ser beneficiário de plano de saúde contratado com a parte ré.

Além disso, a necessidade do tratamento requerido pelo autor resta demonstrado pelos documentos de fls. 423/48, sendo que consta indicação prescrita pelo médico neurologista MARCÍLIO DELMONDES GOMES (CRM/MS 2659), nos seguintes termos:

LAUDO MÉDICO

Este tem por objetivo informar que o Sr. Pablo Neves Chaves, 28 anos, RG: 001572301 SSP/MS e CPF: 050.509.891-16, apresenta Diagnóstico de Narcolepsia Tipo I (Narcolepsia com Cataplexia), CID_{10} - G47.4, confirmado clínica e laboratorialmente (Polissonografia + Testes das Múltiplas Latências do Sono = 25/04/2012), cujos sintomas clínicos tiveram início na adolescência, com hipersonolência diurna, paralisia do sono, cataplexia (perda do tônus muscular global em resposta a estímulos emocionais), alucinações hipnagógicas e hipnopômpicas, resultando em grande impacto negativo na vida diária (estudos, trabalho, lazer e vida social). Desde o início do quadro fez uso de uma série de antidepressivos para controle da cataplexia e humor (únicas opções no Brasil e off- label), com melhora parcial, transitória e uma série de efeitos colaterais, dado as dosagens necessárias para tal. Da mesma forma, para melhora da hipersonolência diurna já fez uso de estimulantes como o Modafinil, Metilfenidato, Armodafinil e Pitalisant (estes dois não disponíveis no Brasil – importados), e, atualmente em uso de Lisdexanfetamina, não tendo resultados satisfatórios com os mesmos, além de não proporcionarem uma resolução completa dos sintomas, bem como uma série de efeitos adversos. Nestes últimos 2 (dois) anos teve um agravamento dos sintomas apresentados, e, como alternativa terapêutica para o caso, está indicado o

[5] **STJ.** RESP 1.923.107/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/8/2021, DJe 16/8/2021

Mod. 990080506 - Endereço: Rua da Paz, nº 14, Jardim dos Estados - 3º andar - Bloco III - CEP 79002-919, Fone: 3317-3369, Campo Grande-MS - E-mail: cgr-5vciv@tjms.jus.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WILSON LEITE CORREA, liberado nos autos em 12/02/2025 às 17:34 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0830954-46.2024.8.12.0001 e código Xj6HINb0.

uso do Oxabato de Sódio, com eficácia comprovada cientificamente, sendo padrão ouro e primeira linha no tratamento da Narcolepsia Tipo I, possuindo indicação em bula para tratamento da enfermidade e é aprovada oficialmente por diversas agências reguladoras. Como já foram realizadas diversas tentativas de tratamento sem sucesso, e tendo a comprovação dos benefícios do Oxabato de Sódio, torna-se imprescindível que o paciente tenha acesso a essa medicação para o seu tratamento.

Oxabato de Sódio= Xyrem (nome comercial fora do Brasil).

Em complemento a tal laudo médico, observa-se do parecer elaborado pela Câmara Técnica de Saúde nos autos de n.º 0808909-95.2013.8.12.0110 anteriormente ajuizado pelo autor, que o autor já realizou tratamento com diversos medicamentos, dentre eles, "Ritalina" e "Stavigile", porém os fármacos não surtiram o efeito desejado no tratamento (fls. 49/52), sendo certo que desta feita nem mesmo o medicamento deferido naqueles autos - Concerta/Cloridrato de Metilfenidato – tem surtido o efeito terapêutico esperado.

Fora isso, deve ser observado que a ANVISA deferiu um requerimento de importação do medicamento Xyrem (Oxibato de sódio) formulado pelo autor, conforme consta do documento de fl. 54.

Corroborando tais elementos de prova, não podemos deixar a margem as disposições constitucionais concernentes a saúde, especialmente aquelas constantes nos artigos 196 e seguintes da Constituição Federal.

Veja-se que o direito à saúde é direito subjetivo indisponível assegurado a todos os cidadãos, sendo constitucionalmente tutelado. Ainda devemos ter em mente que o direito à saúde nada mais é do que um corolário do direito à vida.

Ademais, restou incontroverso que a parte ré não autorizou o tratamento indicado pelo médico especialista, ou seja, refugou o tratamento indicado pelo médico do autor.

Deve ser considerado, também, que o E.TJ/MS já decidiu

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WILSON LEITE CORREA, liberado nos autos em 12/02/2025 às 17:34 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0830954-46.2024.8.12.0001 e código Xj6HINb0.

em casos análogos:

> ***"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – CRIANÇA AUTISTA COM EPILEPSIA – CANABIDIOL – AUSÊNCIA DE REGISTRO NA ANVISA – EXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO EXCEPCIONAL PARA IMPORTAÇÃO – IMPRESCINDIBILIDADE – RETORNO DOS AUTOS PELA VICE-PRESIDÊNCIA PARA REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – RESP 1.657.156/RJ (TEMA 106) – RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDA. Hipótese em que se analisa a matéria decidida no acórdão em relação ao julgamento ocorrido em sede de repercussão geral no Resp 1.657.156/RJ - Tema 106. Diante da ausência de alternativa terapêutica e da imprescindibilidade do medicamento, compete aos entes públicos a importação do canabidiol, a fim de garantir o direito constitucional à saúde da criança enferma" ([6])***
>
> ***"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PLANO DE SAÚDE - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – DOENÇA RARA – OBRIGATORIEDADE – TEMA 990 DO STJ – AFASTADO – NECESSIDADE DE DISTINGUISHING – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. O entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos EREsp nº 1.886.929 e EREsp nº 1.889.704 restou superado pela superveniência da Lei nº 14.454, de 21 de setembro de 2022, a qual alterou a Lei nº 9.656/1998, a fim de estabelecer critérios que permitem a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. Desse modo, não há mais falar em taxatividade do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar editado pela ANS. De acordo com a novel lei, havendo cobertura da moléstia que acomete o segurado pelo plano de saúde contratado, a operadora deverá autorizar a cobertura do tratamento ou procedimento prescrito pelo médico ou odontólogo assistente, ainda que não previsto no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar da ANS, exigindo-se, nesse caso, apenas o enquadramento da casuística em uma das hipóteses previstas no § 13 do art. 10 da Lei nº 9.656/1998. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial repetitivo, firmou entendimento de que "as operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA" (Tema 990), todavia, tratando de doença rara ou ultrarara há substancial diferença material entre o caso em julgamento e os paradigmas, suficiente a amparar a necessidade de não aplicação da "ratio decidendi" dos precedentes que deram ensejo ao Tema 990/STJ ("distinguishing") Recurso conhecido e não provido" ([7]).***

Dessa forma, a requerida não poderia negar o fornecimento

[6] **TJMS.** Agravo de Instrumento n. 1403866-26.2020.8.12.0000, Sonora, 2ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Julizar Barbosa Trindade, j: 14/04/2021, p: 16/04/2021.

[7] **TJMS.** Agravo de Instrumento n. 1404900-94.2024.8.12.0000, Campo Grande, 5ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Alexandre Raslan, j: 30/04/2024, p: 03/05/2024.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WILSON LEITE CORREA, liberado nos autos em 12/02/2025 às 17:34 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0830954-46.2024.8.12.0001 e código Xj6HINb0.

do tratamento solicitado pelo médico responsável pelo acompanhamento da saúde do requerente.

Portanto, comprovada a necessidade de realização do tratamento com o uso do medicamento XYREM® - oxibato de sódio, e não havendo nos autos qualquer motivo para infirmar a veracidade do que foi atestado pelo médico do paciente, o pedido de obrigação de fazer deve ser julgado procedente, ratificando-se os termos da decisão que concedeu a tutela de urgência à parte autora, sendo que, desta feita, por tempo que durar a prescrição médica.

II.II.II – DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

No que pertine à caracterização do dano moral, são pertinentes as lições sempre atuais de Yussef Said Cahali "***Na realidade, multifacetário o ser anímico, tudo aquilo que molesta a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como dano moral***;" ([8]).

No tocante ao pedido de indenização pelos danos morais, não vislumbro a presença dos pressupostos da reparação civil, porquanto o mero descumprimento contratual, por si só, não enseja o dever de indenizar, cabendo à parte autora comprovar a presença dos demais requisitos da responsabilidade civil, como o nexo de causalidade, a culpa e o dano, uma vez que a questão posta em debate não se enquadra nas hipóteses de dano moral presumido.

Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência do E. STJ, consoante a qual ***"(...) Em relação aos danos morais, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. É necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar***

[8] Dano Moral, ed. RT., 2000, p. 20.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WILSON LEITE CORREA, liberado nos autos em 12/02/2025 às 17:34 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0830954-46.2024.8.12.0001 e código Xj6HINb0.

dor e sofrimento indenizável por sua gravidade (...)" ([9])

Considerando que não há nos autos qualquer demonstração de que a parte autora chegou a vivenciar um verdadeiro abalo de ordem moral, capaz de afetar o seu equilíbrio ou integridade emocional, à sua personalidade, trata-se de mero dissabor, de modo que descabida condenação a esse título.

III - DISPOSITIVO

Posto isso, nos termos da fundamentação supra e com respaldo nos arts. 422, 423 e 424, 186 e 927, todos do Código Civil, bem como arts. 6.º, VIII, e 7.º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, **JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS** formulados na petição inicial para **condenar** a requerida em fornecer/custear o tratamento com o uso do medicamento XYREM® - oxibato de sódio.

Por consequência, **ratifico os termos da decisão que concedeu a tutela de urgência de fls. 108/117, desta feita, pelo prazo da prescrição médica.**

Intime-se a requerida pessoalmente para cumprimento.

Tendo em vista que a sucumbência no caso em tela foi recíproca, condenam-se ambas as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, proporcionalmente (metade).

No que se refere aos honorários advocatícios, diante da sucumbência recíproca passo a proceder a respectiva individualização.

Diante do parcial julgamento de procedência, condeno a requerida no pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora,

[9] **STJ**. AgInt no REsp 1955167/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WILSON LEITE CORREA, liberado nos autos em 12/02/2025 às 17:34 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0830954-46.2024.8.12.0001 e código Xj6HINb0.

os quais, à vista do grau de zelo do profissional (bom), o local de prestação de serviço (atendimento na sede da Comarca), a natureza e a importância da causa (pouca complexidade) e os atos processuais praticados (feito não instruído), fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, §8º, do mesmo Código.

Pelos mesmos fundamentos, condeno a parte autora no pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da requerida, os quais fixo em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade fica suspensa nos termos do art. 98, §3º, do mesmo Código.

Julgo resolvido o mérito da causa na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

P.R.I.

Campo Grande/MS, *data do sistema*.

Wilson Leite Corrêa
Juiz de Direito
Documento assinado digitalmente

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por WILSON LEITE CORREA, liberado nos autos em 12/02/2025 às 17:34 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0830954-46.2024.8.12.0001 e código Xj6HINb0.